LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichoń

PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej

Nr procedury:	01/2026
Wersja:	1.0
Data:	07.06.2026
Zatwierdził:	

1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ujednolicenie zasad i określenie sposobu postępowania w zakresie przeprowadzania wewnętrznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej w placówce, co pozwala na systematyczne monitorowanie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych, wczesną identyfikację nieprawidłowości i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje kadrę zarządzającą oraz osoby wyznaczone do przeprowadzania audytów i kontroli wewnętrznych w placówce. Dotyczy całego obszaru działalności medycznej i pozamedycznej mającej wpływ na stan sanitarno-epidemiologiczny.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wdrożenie, nadzór oraz aktualizację procedury odpowiada **Kierownik / Właściciel**.
2. Za rzetelne i terminowe przeprowadzanie kontroli oraz wypełnienie protokołu odpowiada **osoba przeprowadzająca kontrolę**.
3. Za wdrożenie zaleceń pokontrolnych i bieżące utrzymanie standardów odpowiada **cały personel placówki**.

4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

Wykaz niezbędnych środków i dokumentów:

- Czysty formularz: "Protokół kontroli wewnętrznej"
- Dostęp do dokumentacji placówki (umowy np. na sterylizację, utylizację odpadów medycznych)
- Dostęp do procedur i instrukcji obowiązujących w placówce
- Teczki osobowe (wgląd w badania sanitarno-epidemiologiczne)

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

1. **Identyfikacja placówki i usług:** Kontrola rozpoczyna się od uzupełnienia ogólnych danych: nazwy placówki oraz rodzaju świadczonych usług.
2. **Ocena procesów sterylizacji:** Należy zweryfikować zasady sterylizacji w placówce (we własnym zakresie lub poprzez zewnętrzną umowę). W przypadku sterylizacji własnej należy sprawdzić parametry, typ i rok produkcji autoklawu oraz stosowane opakowania. Dodatkowo trzeba skontrolować, czy pakiety mają datę sterylizacji, ważności oraz czy proces jest odpowiednio oznakowany (np. wydruk z metkownicy) i powiązany z pacjentem.
3. **Ocena procedur dezynfekcji:** Należy przeanalizować stosowane preparaty do dezynfekcji sprzętu i powierzchni, wpisując do protokołu ich nazwę, stężenie, czas działania i zastosowanie, oraz upewnić się, że są one przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.
4. **Ocena gospodarki odpadami medycznymi:** Osoba kontrolująca weryfikuje miejsca i czas przechowywania odpadów, sposób ich zabezpieczenia oraz sposób i firmę odpowiedzialną za ich utylizację.
5. **Ocena higieny i środków ochrony:** Sprawdzane jest utrzymanie czystości, stosowany do sprzątania sprzęt, rodzaj stosowanych antyseptyków do rąk oraz dostępność i rodzaj środków ochrony osobistej personelu.
6. **Przegląd dokumentacji systemowej:** Kontrolujący weryfikuje obecność, aktualność i znajomość podstawowych procedur sanitarno-epidemiologicznych wymaganych w protokole (m.in. procedury mycia, dezynfekcji, plan higieny, procedury postępowania z odpadami).

7. **Badania personelu:** Sprawdzana jest ważność badań sanitarno-epidemiologicznych właściciela oraz zatrudnionych pracowników.
8. **Zakończenie i podsumowanie:** Protokół z kontroli podpisuje osoba kontrolująca. Dokument powinien być opatrzony datą, a wnioski przekazane kierownictwu do ewentualnych działań korygujących.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli krytycznych nieprawidłowości (np. przeterminowanych pakietów sterylnych lub braku środków ochrony), należy niezwłocznie wstrzymać świadczenie usług w danym obszarze do czasu usunięcia zagrożenia.

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Formularz: Protokół kontroli wewnętrznej
2. Książka kontroli wewnętrznych (jeśli jest prowadzona)
3. Instrukcja przeprowadzania kontroli wewnętrznej